

HISTORIA CLÍNICA DE FISIATRÍA

SE REALIZA ATENCIÓN DEL PACIENTE POR CONSULTA, PREVIAMENTE CONFIRMADA POR VÍA TELEFÓNICA, CON ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO DE SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA Y FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO CORRESPONDIENTE, POR PARTE DEL PACIENTE ANTERIOR A LA CONSULTA. SE ATIENDE PACIENTE PREVIA DESINFECCIÓN DEL ÁREA DEL CONSULTORIO, CON TODAS LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD; LAVADO DE MANOS PREVIO, USO DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PREVIO A LA CONSULTA, USO DE TAPABOCAS N95, USO DE VISOR PANORÁMICO, USO DE BATA ANTIFLUÍDOS, USO DE GUANTES DESECHABLES PARA SU EXÁMEN FÍSICO

FECHA: 2025-03-21 15:07:32

NOMBRE: SANTIAGO ROJAS RODRIGUEZ

DIRECCION: ERA ETAPA MZ 1 CA 5

BARRIOS: LOS QUINDOS

EPS: EPS SURA

EDAD: 22

SEXO: M

HC: 1004683619

TELEFONO: 3207444882

MOTIVO DE CONSULTA: MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (FISIATRÍA)
CONTROL

Paciente de 22 años con Dx:

1. Parálisis cerebral tipo hemiparesia espástica izquierda
2. Déficit cognoscitivo secundario
3. Asimetría de MMII
4. Antecedente de corrección de coxa valga izquierda - MAOS en fémur y en acetábulo (2017)

** Rx panorámica columna (22 junio 2023 - Radiólogos): Acortamiento de MI izquierdo de 24 mm, genu varo bilateral, presencia de material quirúrgico en alerón iliaco izquierdo, cuello femoral y en región transtrocanterica, disminución de altura en el espacio femoro acetabular izquierdo.

>> Última consulta: Paciente con parálisis cerebral tipo hemiparesia espástica izquierda. Se beneficia de uso de miorelajante y de ortesis más liviana dado que la alteración es dinámica. Se ordena:

- Baclofeno 10 mg cada 8 horas.- Ortesis tobillo pie en fibra de carbono, con pilón posterior recto, sujeción por velcros proximales y material de la suela que se pueda cortar para ajuste al calzado. Adicionar realce en material semirrígido de 2.5 mm en retropié que disminuya hasta 0 mm en mediopié.

Asiste con Soledad Rodríguez (madre).

ANTECEDENTES:

** Neuropsicología 16/08/2023 Motricidad fina y gruesa: Dificultad para amarrarse los zapatos, cierta dificultad motriz gruesa por antecedente médico. Cierta dificultad en la mecánica de la escritura Independencia en Actividades Instrumentales (AIID): Muestra la capacidad de transportarse solo y trasladarse, manejo del dinero. Atención y concentración: Sin dificultades atencionales Lenguaje: Adecuada comprensión y expresión verbal Memoria: Sin dificultades aparentes Percepción: Uso de gafas permanentes, adecuada audición Comportamiento y estado de ánimo: Baja tolerancia a la frustración, irritabilidad.

>> Dr Arias 01/06/2023 lesión cerebral neonatal, hemiparesia izq. pobre prehensión palmar izq., acortamiento de MII aprox. 5 cm, manejo con bota ortopédica de 10 cm, solicitó Rx panorámica de MI, ortesis braquiopalmar izq. para uso nocturno y ortesis dinámica muñeca y dedos zq. con resortes para ext. de dedo medio y anular,

** Rx panorámica de MI MID de 82.5 cm izq. de 80.1 cm diferencia de 24 mm, genu varo bilateral. RGE, hipercalcemia

Cx corrección de coxa izq. con MAOS en fémur y acetábulo 2017, varias en MSI, apendicectomía También recibió toxina botulínica en antebrazo izq. (3 aplicaciones)

ENFERMEDAD ACTUAL: Inició baclofeno, con percepción de disminución en el tono muscular. Adecuada tolerancia.

Pendiente entrega de ortesis, ya en proceso.

EXPLORACIÓN FÍSICA: Buen estado general.

Ingresa caminando por sus medios.

Acude al examen físico.

Marcha hemiparética izquierda.

Ashworth 2 en flexores del codo, del carpo y de los dedos, en aductores de cadera, flexores de rodilla y plantiflexores.

Codo con actitud en flexión que pasivamente llega a extensión total

Muñeca en actitud de extensión de 45 grados, pasivamente llega a neutro.

Hiperreflexia ++++ rotuliana y aquiliana, con clonus agotable en este último nivel.

Flexión MCF e IF de dedos 2 a 5.

Ortesis tobillo pie en polipropileno, articulada y con tope a la plantiflexión.

Marcha con inclinaciones laterales del tronco, ausencia de paso escapular, pie caído dinámico y sobreposición de segundo artejo sobre el primero.

PLAN DE MANEJO: Paciente con buena respuesta a manejo miorrelajante, especialmente a nivel de miembro superior.

Se aumenta dosis a 20-20-10 mg.

Cita control.

DIAGNOSTICO PPAL: G801-PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA DIPLEJICA

DIAGNOSTICO RELACIONADO 1: R268-OTRAS ANORMALIDADES DE LA MARCHA Y DE LA MOVILIDAD Y LAS NO ESPECIFICADAS

DIAGNOSTICO RELACIONADO 2:

DIAGNOSTICO RELACIONADO 3:



Pida su cita a través del portal
www.agendamedicacolombiana.com

CAMILO HERNANDO CHAVES ANGARITA

REG MEDICO: 80032574

ESPECIALIDAD: FISIATRIA

Carrera 10 # 14 norte 59 Barrio La Campiña

Telefono Fijo: 7362260

Telefono Celular: 3217126990 - 3022242435

Whatsapp: 3217126990

Correo Electronico: auxadministrativo1@clinicaneuromental.com - servicioalcliente@clinicaneuromental.com - citas@clinicaneuromental.com - gerencia@clinicaneuromental.com

Unete al grupo de padres en Facebook o Instagram: Neuromental - Pagina web: www.clinicaneuromental.com